

УДК 616.6:615.277

К.В.Артемов, Ю.В.Войновский, Ж.Х.Мукашева, Г.Н.Нурланова, К.Б.Улыбаев
ГКП на ПХВ Алматинский региональный онкологический диспансер

Применение антидепрессанта миртазапин в онкологической практике

Аннотация. Онкологические пациенты значительно отличаются от соматических больных, готовящихся к оперативным вмешательствам, по показателю эмоциональной лабильности. За последние десятилетия получены данные о большой распространённости у больных с онкопатологией т.н. дезадаптивных состояний в ответ на серьёзное заболевание по типу нозогений. Чем более объёмное вмешательство планируется, тем больше дезадаптация пациента. В онкологической клинике приходится значительно чаще сталкиваться с тревожными расстройствами и депрессивными состояниями, чем в общехирургической. Онкологическим больным необходима психофармакологическая и психотерапевтическая коррекция. В данной статье представлены результаты клинического применения антидепрессанта миртазапин в онкохирургической практике. Антидепрессант миртазапин позволяет провести коррекцию таких психопатологических расстройств, как тревожная депрессия, остроразвивающиеся панические расстройства, бессонница, снизить уровень ипохондрической фиксации на субъективно-переживаемых неприятных ощущениях, что создаёт основу для конструктивного взаимодействия больного и врача. Данный препарат позволяет снизить уровень психического страдания, повысить качество жизни больного, актуализировать надежду на благоприятный исход болезни, создать устойчивую мотивацию на лечебный процесс, нередко сопряженный с серьёзными вмешательствами и сопровождающийся тягостными переживаниями.

Ключевые слова: онкохирургия, тревожно-депрессивный синдром, антидепрессанты, миртазапин.

Актуальность

Онкологические пациенты значительно отличаются от соматических больных, готовящихся к оперативным вмешательствам, по показателю эмоциональной лабильности [1,2,3]. За последние десятилетия получены данные о большой распространённости у больных с онкопатологией т.н. дезадаптивных состояний в ответ на серьёзное заболевание по типу нозогений [4]. Чем более объёмное вмешательство планируется, тем больше дезадаптация пациента. Анестезиологам и хирургам в онкологической клинике приходится значительно чаще сталкиваться с тревожными расстройствами и депрессивными состояниями, чем в общехирургической [4,5]. Психические расстройства различной степени выраженности (от психологических до нозологических реакций на диагноз и прогноз заболевания до острых психозов) при онкологической патологии — частое явление, наблюдаемое как онкологами, так и

психиатрами и психологами [3,4,5]. В настоящее время ни у кого не возникает сомнений в том, что у онкологических больных отмечается повышенный уровень тревожно-депрессивных расстройств относительно других психосоматических групп [3,6]. Этому способствуют не только выраженные патологические изменения, вызванные, собственно, опухолевым процессом, сопровождающиеся деструктивными повреждениями структуры и функции того или иного органа и его тканей с болевыми синдромами, интоксикацией продуктами распада опухоли, общей астенизацией, но и высокая степень психического страдания, зачастую превышающая интенсивность физического. По данным исследования депрессий и расстройств депрессивного спектра в общемедицинской практике [7], 38% пациентов, имеющих онкологические заболевания ($ces > 25$), страдают выраженными депрессиями, требующими психофармакологической коррекции антидепрессантами той или иной группы. Депрессивные расстройства, в том числе и тревожная депрессия, сами приводят к выраженным нейрохимическим, гормональным и иммунологическим сдвигам гомеостаза, способствующим прогрессированию опухолевого процесса и значительно влияющим на отдаленные результаты лечения больных. Известно, что при депрессии снижается активность биогенных аминов, компенсаторно повышается активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, приводящая к повышению секреции кортизола [1,6], за счет чего происходит торможение иммунных функций, играющих немаловажное, если не решающее значение в элиминации генетически измененных клеток организма. Для поликлинического (диагностического) этапа, начинающегося с первых контактов больного с онкологической службой, а часто с направления пациента врачами общей практики к онкологу для осмотра и решения вопроса о необходимости госпитализации и оперативного лечения, характерным считается тревожно-депрессивный синдром (Бажин Е.Ф., Гнездилов А.В.). Его частота составляет до 56% от всех случаев обращения больных в онкологические клиники [2].

В Алматинском региональном онкологическом диспансере с 2012 года успешно применяется психофармакологическая подготовка больных к предстоящему оперативному вмешательству [8]. Суть метода заключается в применении, непосредственно перед операцией, препарата из группы анксиолитиков этифоксина гидрохлорид по 50 мг три раза в день за день до оперативного вмешательства, что способствует снижению уровня базовой тревожности, и повышает готовность и мотивацию больного на предстоящую операцию. Тем не менее, существует значительная часть пациентов, у которых изолированный анксиолитический эффект коррекции психического состояния этифоксина гидрохлоридом является недостаточным, в силу того, что анксиолитики не влияют на выраженный депрессивный компонент тревожно-депрессивного синдрома, а отсутствие у препарата седативного эффекта не решает наличие ин-

Таблица 1- Шкала Гамильтона для оценки депрессии (HamiltonDepressionRatingScale)

Пункт шкалы	Показатели – обвести соответств. значение				
	0	1	2	3	4
Тревожное настроение – озабоченность, ожидание наихудшего, тревожные опасения, раздражительность.	0	1	2	3	4
Напряжение – ощущение напряжения, вздрагивания, легко возникающая плаксивость, дрожь, чувство беспокойства, неспособность расслабиться	0	1	2	3	4
Страхи – темноты, болезней, незнакомцев, одиночества, животных, толпы, транспорта	0	1	2	3	4
Инсомния – затрудненное засыпание, прерывистый сон, не приносящий отдыха, чувство разбитости и слабости при пробуждении, суточные колебания настроения.	0	1	2	3	4
Интеллектуальные нарушения – затруднение концентрации внимания, ухудшение памяти.	0	1	2	3	4
Депрессивное настроение – утрата привычных интересов, чувства удовольствия от хобби, подавленность, ранние пробуждения, суточные колебания настроения.	0	1	2	3	4
Соматические мышечные симптомы – боли, подергивания, напряжение, клонические судороги, скрипение зубами, срывающийся голос, повышенный мышечный тонус.	0	1	2	3	4
Соматические сенсорные симптомы – звон в ушах, нечеткость зрения, приливы жара и холода, ощущения слабости, покалывания.	0	1	2	3	4
Сердечнососудистые симптомы – тахикардия, сердцебиение, боль в груди, пульсация в сосудах, частые вздохи.	0	1	2	3	4
Респираторные симптомы – давление и сжатие в груди, удушье, частые вздохи.	0	1	2	3	4
Гастроинтестинальные симптомы – затруднение глотания, метеоризм, боль в животе, изжога, диарея, запоры, чувство переполненного желудка, тошнота, рвота, урчание в животе, снижение веса тела.	0	1	2	3	4
Мочеполовые симптомы – учащенное мочеиспускание, сильные позывы на мочеиспускание, аменорея, меноррагия, фригидность, преждевременная эякуляция, утрата либидо, импотенция.	0	1	2	3	4
Вегетативные симптомы – сухость во рту, покраснение или бледность кожи, потливость, головные боли с чувством сжатия и напряжения.	0	1	2	3	4ё
<i>Примечание: По каждому пункту шкалы устанавливается оценка по следующему критерию: 0 – отсутствие; 1 – в слабой степени; 2 – в умеренной степени; 3- в тяжелой степени; 4- в очень тяжелой степени.</i>					

сомнических проблем у некоторых больных. В связи с этим обстоятельством, у некоторых больных с указанными выше расстройствами, возникает необходимость дополнения медикаментозной подготовки препаратом с антидепрессивным воздействием.

В комплексе мероприятий по устранению депрессивного компонента мы предлагаем использовать препарат миртазапин [9]. Выбор миртазапина был обусловлен сочетанием как антидепрессивных, так и противотревожных и антипанических свойств с достаточно выраженным седативным эффектом, что является весьма ценным свойством при нередко встречающейся у онкобольных инсомнии, сопряженной как с депрессией, так и с тревогой. Возможно применение препарата на срок до 1-3 месяцев. В отличие от антидепрессантов других групп, клинически значимая седация развивается через час после приема первой дозы препарата, в отличие от трициклических антидепрессантов его отличают невысокая токсичность, быстрое достижение антидепрессивного эффекта и хорошая переносимость больными без нежелательных первичных эффектов (тахикардии, тремора, потливости и ажитации). Это имеет решающее значение в формировании приверженности и доверия к антидепрессивной терапии весьма мнительными онкологическими больными, склонными прислушиваться к малейшим неприятным ощущениям, и зачастую, без того

сталкивающимися с побочными эффектами противоопухолевых химиотерапевтических препаратов.

Цель исследования

– определить возможность применения антидепрессанта миртазапин в комплексе средств психофармакологической коррекции у онкологических больных.

Материал и методы

В качестве антидепрессанта применялся препарат миртазапин (Миртел, производства GerotLannacher, Австрия) в дозировке от 15 до 30 мг в сутки за 1 час до сна. Длительность приёма составила от одного дня до пяти дней.

Критериями назначения антидепрессанта являлись клиничко-психопатологические и психометрические (в случаях маскированной депрессии - свыше 8 баллов по шкале для оценки депрессии Hamilton) результаты обследования больного [10,11]. По адаптированной шкале Гамильтона для психометрической оценки депрессий рассматривались следующие критерии: тревожное настроение, напряжение, страхи, инсомния, интеллектуальные нарушения, депрессивное настроение, соматические мышечные симптомы,

Таблица 2 - Результаты наблюдений

Группы больных	Больной/ Диагноз	Суммарная оценка баллов по шкале Гамильтона до приема миртазапина	Суммарная оценка баллов по шкале Гамильтона перед операцией	Суммарная оценка баллов по шкале Гамильтона перед выпиской.
1 день до операции	Б-ная С., 1964г.р. С-г левой молочной железы	16	11	11
	Б-ная Ж., 1961г.р. Меланома кожи лица	24	17	12
	Б-ная М., 1958г.р. Остеос-а правой голени	17	13	10
	Б-ная Т., 1961г.р. Миома матки, С-г левой молочной железы	19	16	8
	Б-ная М., 1963г.р. С-г правой молочной железы	15	13	12
	Б-ная Т., 1973г.р. С-г левой молочной железы	18	13	10
	Б-ной Б., 1945г.р. С-г антрального отдела желудка	18	14	13
3 дня до операции	Б-ной Д., 1951г.р. С-г сигмовидной кишки.	26	19	16
	Б-ная Ш., 1967г.р. С-г правой молочной железы	25	17	13
	Б-ная С., 1974г.р. С-г правой молочной железы	22	18	17
	Б-ная А., 1960г.р. С-г правой молочной железы	27	20	14
	Б-ной Г., 1942г.р. С-г прямой кишки	23	19	16
	Б-ная Б., 1958г.р. С-г правого легкого	25	20	16
5 дней и более до операции	Б-ная С., 1942г.р. С-г левой молочной железы	24	15	10
	Б-ной Б., 1941г.р. С-г простаты	23	17	10
	Б-ной Н., 1970г.р. С-г желчного пузыря	18	11	7
	Б-ная Б., 1955г.р. С-г правой молочной железы	25	14	12
	Б-ной Н., 1960г.р. С-г левого легкого	28	22	14
	Б-ная Б., 1979г.р. С-г шейки матки	23	20	10
	Б-ная Б., 1993г.р. Лимфогранулематоз	27	17	11

соматические сенсорные симптомы, сердечнососудистые симптомы, респираторные симптомы, гастроинтестинальные симптомы, мочеоловые симптомы, вегетативные симптомы. Оценка депрессии проводилась в баллах: 1- слабой степени, 2- умеренной, 3- тяжелой степени, 4- очень тяжелой степени. Отсутствием депрессивного состояния считается от 0 до 7 баллов, 8 – 19 баллов- легкое депрессивное состояние, а от 20 и выше – выраженная депрессия. За 3 последних месяца необходимость в назначении анти-депрессанта была отмечена у 21 пациента.

Полученные результаты

В ходе наблюдения было отмечено, что при назначении миртазапина довольно быстро (в течение 1-5 дней) происходило снижение выраженности как тревожных, так и депрессивных расстройств, и почти во всех случаях (за исключением случаев с наличием выраженных болевых синдромов) нормализовался сон. Основные позиции, по которым отмечалось улучшение психического состояния

касались таких параметров, как инсомния (улучшение от 2 до 4 баллов), напряжение (улучшение от 1 до 4 баллов), соматические мышечные и сенсорные симптомы (улучшение в сумме от 3 до 6 баллов), вегетативные симптомы (улучшение от 1 до 4 баллов), депрессивное настроение (улучшение от 1 до 2 баллов).

Необходимо заметить, что возможно, на некоторые компоненты оцениваемых параметров оказала влияние и параллельно проводимая психотерапевтическая работа с пациентами. Мы не можем также полностью исключить влияние положительного плацебо-эффекта, однако в целом, применение миртазапина заметно и существенно изменило картину психического состояния больных, готовящихся к операции, по сравнению с обычным в нашей клинике применением анксиолитика и психотерапии.

Практически во всех случаях, на фоне проводимой антидепрессивной терапии, в сочетании с психотерапевтическим пособием отмечено существенное улучшение качества жизни, как субъективно переживаемого психического состояния больных, коррекция инсомнии, облег-

чение продуктивного взаимодействия «врач-больной» и повышение доверия пациента к проводимым хирургическим и последующим химиотерапевтическим вмешательствам. Выраженных побочных эффектов препарата и нежелательных взаимодействий с другими лекарствами за время наблюдения не отмечалось.

В одном из случаев нами наблюдался отчетливый, быстрый и стойкий положительный антидепрессивный и противотревожный ответ на назначение препарата в случае отказа от оперативного лечения у больной Б., 35 лет, история болезни № 558-89, на фоне остро развившегося тревожно-фобического эпизода. После отказа от операции непосредственно перед её проведением, с больной была проведена психотерапевтическая беседа, был предложен прием миртазапина в суточной дозе 30 мг на ночь. Через три дня приема у больной снизился уровень аффективного напряжения, фон настроения стабилизировался настолько, что она смогла конструктивно подойти к решению вопроса о необходимости хирургического лечения, и через семь дней приема миртазапина больная была успешно прооперирована.

Выводы

По нашему мнению, применение миртазапина в средних терапевтических дозировках является безопасным, эффективным и достаточным, а порою необходимым не только на этапе подготовки больных к оперативному вмешательству, но и в повседневной практике на всех этапах работы с больным – от постановки диагноза, до выписки из стационара и последующего амбулаторного наблюдения.

Малое количество наблюдений при применении миртазапина в онкохирургии не позволяет сделать более глубокие выводы. Данное исследование является первым этапом в изучении возможностей применения антидепрессанта миртазапин в комплексе средств психофармакологической коррекции у онкологических больных.

Список литературы

- 1 G.Caplan, B.Sadoc. Клиническая психиатрия //Под ред. Т.Б. Дмитриевой. –М., 1999. - С. 215 – 217.
- 2 Бажин Е.Ф., Гнездилов А.В. О психогенных реакциях у онкологических больных // Журнал невропатологии и психиатрии. - 1980. - № 8. - С.1198-1204.
- 3 Гнездилов А.В.. Психические изменения у онкологических больных. // Практическая онкология. -2001. - №1 (5). –С 5-6.
- 4 Русина Н.А. Адаптационные ресурсы пациентов онкологической клиники // Bulletin of Medical Internet Conferences. - 2011. -Vol.1, № 7. - P.92-94.
- 5 Володин Б.Ю., Петров С.С., Куликов Е.П. Психиатрия и психотерапия в онкологической практике. Учебное пособие // Ряз. гос. мед.ун-т им. акад. И.П.Павлова. – Рязань: РИО РГМУ, 2006. - 83 с.
- 6 Вальдман А.В. Боль как эмоционально-стрессовая реакция и способы ее антиноцицептивной регуляции //Вести АМН СССР. -1980. -№ 9. -С.11- 17.
- 7 Оганов Р.Г., Ольбинская О.М., Смулевич А.Б. и др. Результаты программы КОМПАС Государственным научно-исследовательским центром профилактической медицины МЗ РФ, НЦПЗ РАМН, ММА им. И.М. Сеченова // Кардиология. -2004. -№ 1. -С. 48-54.
- 8 Войновский Ю.В., Олжаев С.Т., Нурланова Г.Н. Применение этифоксина гидрохлорида для подготовки онкобольных к анестезии//Анестезиология и реаниматология Казахстана. -

2013. - №1(10). -С. 59-61.

9 Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства МИРТЕЛ.

10 Hamilton M. The assessment of anxiety states byrating//Br. J.Med.Psychol. -1959. -Vol. 32. -P.50-55.

Тұжырым

К.В.Артёмьев, Ю.В.Войновский, Ж.Х.Мукашева, Г.Н.Нурланова Қ.Б.Ұлыбаев

ГКП на ГХВ Алматылық аймақтық онкологиялық диспансәрі Онкохирургиялық тәжірибеде миртазепин антидепрессантының қолданылуа

Онкологиялық аурулармен ауыратын науқастар басқа соматикалық аурулармен ауыратын науқастарға қарағанда отаға дайындау барысында эмоциональды лабильділігі жағынан ерекше болып табылады. Ауру түріне байланысты соңғы он жылдықта онкопатологиямен ауыратын науқастарда дезадаптивті жағдайлар кең таралғаны жайлы мәліметтер көп кездесіп жүр. Негізгі үлкен оталар жоспарланса, соғұрлым науқастардың дезадаптациясы үлкейе түсетіні байқалды. Жалпы хирургиялық тәжірибедегі анестезиолог дәрігерлеріне қарағанда онкохирургиядағы мамандар, науқастар көңіл күйі бұзылыстары және депрессивті жағдайлармен көп кездесіп отырады. Онкологиялық науқастарға психофармакологиялық және психотерапиялық түзетулер қажет болып табылады. Бұл жұмыста онкохирургиялық тәжірибеде антидепрессант миртазапинді қолдану көрсетілген. Антидепрессант миртазапин мазасыздық депрессиясы, жөдел пайда болатын үрей бұзылыстары, ұйқысыздық, ипохондриялық тұйықталуға алып келетін субъективті уайым бұзылыстары сияқты психопатологиялық ауытқуларды түзетуге себебін тигізеді, яғни дәрігермен науқас арасындағы тығыз түсінушілікпен байланысты қалыптастыруға себебін тигізеді. Бұл дәрі жиі ауыр уайымдаулармен жүретін маңызды ем-шаралар кезіндегі психикалық жарақаттану көлемін азайтуға, науқастың өмір сүру көрсеткішін жақсартуға, ауру емделуінің оң нәтижелі болуына, емге деген дұрыс оң көзқарас қалыптастыруға себебін тигізеді.

Түйінді сөздер: онкохирургия, мазасыздық-депрессивті синдромы, антидепрессанттар, миртазапин.

Summary

K. V. Artemev, Y. V. Voinovskiy, Zh. Kh. Mukasheva, G. N. Nurlanova, K. B. Ulybayev

PCG on PVC Almaty Regional Oncology Center

Application of antidepressant mirtazapine in oncosurgery practice

Oncological patients working themselves up to surgical intervention more differ from somatic one in emotional lability factor. Over the past few decades, there was received the information about the great occurrence of patients with oncopathology became known as disadaptive conditions, in answer to serious disease in the type of nosogeny. If the more solid intervention is planning so the more dysadaptation of patient is being. It have to deal with anxious disorder and depressive position more often in oncological clinic than in general surgical clinic. Oncological patients need in psychopharmacological and psychotherapeutic correction. The results of clinical application of antidepressant mirtazapine in oncosurgery practice are shown in this article. Antidepressant mirtazapine let to realize the correction such psychopathological dissociations as worried depression, developmental panic disorder, insomnia, recession of level of hypochondriac anchorage on egocentric experience of sense of discomfort that is create the base for structural interaction between patient and doctor. This preparation let to decrease the level of psychical illness, to increase quality of life of patient, to actualize the expectation for productive clinical outcome and also to create the tolerant motivation for direct care that is not unfrequently connected with serious intervention and accompanied by emotional stress bothersome.

Keywords: oncosurgery, anxiodepressive syndrome, antidepressants, mirtazapine.